

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE CONTRARREFERENCIA (RECEPCIÓN Y CONTRA-REMISIÓN)	Código: PRD-RYC-02 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	---

PROCEDIMIENTO DE CONTRARREFERENCIA (RECEPCIÓN Y CONTRA-REMISIÓN)

1. OBJETIVO

Definir la ruta para la recepción, análisis y articulación de la información clínica de los pacientes que retornan al consultorio psicológico tras haber sido valorados por otra especialidad (contrarreferencia), o que son derivados por primera vez desde medicina general.

2. ALCANCE

Aplica a todo paciente que ingrese al consultorio con una remisión externa (contra-remisión) o que retorne con indicaciones de manejo farmacológico/psiquiátrico que impacten su proceso psicoterapéutico.

3. RESPONSABLES

- Profesional en Psicología Tratante.
- Personal Administrativo (Recepción de documentos).

4. MARCO NORMATIVO

- Resolución 3100 de 2019.

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

- 5.1. Recepción del Documento de Contrarreferencia: Al recibir al paciente, solicitar el resumen de historia clínica, nota de evolución o formato de contrarreferencia emitido por el especialista (ej. Psiquiatra) al que fue remitido previamente.
- 5.2. Análisis Interdisciplinario: El profesional en psicología leerá y analizará las indicaciones, diagnósticos o ajustes farmacológicos realizados por la otra especialidad. Esto es vital para comprender cambios en el estado de ánimo o efectos secundarios de la medicación que puedan influir en la terapia.

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE CONTRARREFERENCIA (RECEPCIÓN Y CONTRA-REMISIÓN)	Código: PRD-RYC-02 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	---

- 5.3. Ajuste del Plan Terapéutico: Con base en la información recibida en la contrarreferencia, el psicólogo ajustará los objetivos de la intervención psicológica para trabajar en sinergia con el tratamiento médico establecido.
- 5.4. Integración al Expediente: El documento físico o digital entregado por el paciente debe ser escaneado o archivado inmediatamente en su historia clínica psicológica para mantener la trazabilidad del manejo integral.
- 5.5. Retroalimentación (Si aplica): En casos de alto riesgo o tratamientos complejos, el profesional en psicología podrá comunicarse directamente con el médico remitente para alinear estrategias, siempre protegiendo el secreto profesional mediante el consentimiento informado del paciente.

6. PUNTOS DE CONTROL PARA AUDITORÍA

- Archivo de los documentos de contrarreferencia (resúmenes médicos) dentro de la historia clínica.
- Evidencia en las notas de evolución de que se ajustó el manejo psicológico con base en la medicación o diagnóstico médico reportado.